

43 - 01-les rhinorrhées - Pr. ROCHDI

Dans le cadre du module de signologie 2, on va commencer cette partie de la signologie ORL en commençant par le chapitre qui va traiter les rhinorées. Les rhinorées se définissent par un écoulement provenant des fosses nasales. Cela peut être un écoulement antérieur, c'est-à-dire à travers les narines, ou un écoulement postérieur, à travers les couades, et qui va être visualisé au niveau de l'oropharynx.

Ou bien, on peut avoir un écoulement mix, c'est-à-dire antérieur et postérieur à la fois. D'abord, un petit rappel sur l'anatomie des fosses nasales. Il faut rappeler que les fosses nasales sont deux cavités au niveau de la face qui sont séparées par la cloison nasale.

Ou bien, on a les cavités nasales auxquelles sont annexées les sinus, avec le sinus maxillaire et ses rapports avec l'arcade dentaire supérieur. Le sinus est unidale, sinus frontal, le cornet inférieur, le cornet moyen et le cornet supérieur. Sur ce schéma-là, on voit très bien la cavité nasale avec les trois cornets inférieur, moyen, supérieur, sinus unidale et sinus frontal.

Vous voyez ici les orifices narinaires. L'écoulement de l'arée norée peut s'écouler à travers la narine ici, ou bien en arrière, à travers les couades, pour descendre au niveau de l'oropharynx. La muqueuse des fosses nasales est une muqueuse respiratoire secrétante qui possède un tas de chimiques auxiliaires qui permet le drainage des secretions nasales.

La vascularisation se fait essentiellement par le système carotidien externe, par le biais de l'artère sphéno-palatine, qui va vasculariser la paroi externe et la cloison nasale. Deuxième élément, c'est les artérithmidales qui proviennent du système carotidien interne, artérithmidales antérieures et postérieures, qui vont vasculariser la partie antérieure des fosses nasales, au niveau de la paroi externe et au niveau de la cloison nasale. A la partie antéro-inférieure de la cloison nasale, qui vient du septum nasale, il y a une anastomose qui se fait entre le système carotidien externe et le système carotidien interne, ce qu'on appelle la tache vasculaire.

C'est une zone de fragilité vasculaire qui est responsable de la majeure partie des épistaxies. Comme on a dit, on peut avoir un écoulement, soit antérieur ou postérieur, et la nature de cet écoulement est variable, soit c'est une rhénorée aqueuse, c'est-à-dire claire, soit elle va être purulente, jaune, ou bien elle va être sanglante, c'est ce qu'on appelle les épistaxies. Vous voyez très bien ici une rhénorée aqueuse chez un enfant, qui est bilatérale, avec un écoulement clair, comme elle peut être purulente, ou bien jaunante.

Alors, qu'est-ce qu'il faut faire devant une rhénorée ? Il faut d'abord commencer par l'interrogatoire. Il faut avoir une idée sur la date de début de la rhénorée, les circonstances déclenchantes, c'est-à-dire, est-ce que c'est une rhénorée spontanée, est-ce que c'est après un traumatisme, après une chirurgie, l'ancienneté de l'écoulement, un écoulement qui est récent, qui date de quelques jours, ou bien c'est un écoulement chronique depuis des mois ou des années,

sa nature, est-ce qu'elle est claire, est-ce qu'elle est purulente, est-ce qu'elle est sanglante, et bien sûr, est-ce qu'elle est unilatérale, ou bien bilatérale. Cet écoulement, ou bien cette rhénorée, est-ce qu'elle est intermittente, c'est-à-dire qu'elle survient quelques fois dans la journée, ou bien elle est permanente, est-ce qu'elle survient pendant quelques mois, ou bien elle est perannuelle, est-ce qu'il y a des signes qui sont accompagnateurs, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une obstruction nasale, unie ou bilatérale, c'est-à-dire l'obstruction nasale, elle peut être homolatérale à la rhénorée, en cas de rhénorée unilatérale, est-ce qu'il y a un prurite nasal, un prurite paranoïde, des éternuements, est-ce qu'il y a une odeur fétive, c'est un symptôme qui est très important, une odeur fétive qu'on appelle les cacosies, ça oriente fortement vers des sinusites bactériennes, ou bien fongiques, souvent d'origine dentaire, est-ce qu'il y a des signes otologiques associés, type otalgie, épaulacose, des acouphères, un mouvement de l'oreille, des algifaciales, algifaciales sous-orbitales, par exemple, algifaciales frontales, ou bien des céphalées, qui peuvent orienter parfois vers des sinusites associées, est-ce qu'il y a une tête chronique, est-ce qu'il y a des symptômes respiratoires, têtes chroniques, sifflements thoraciques, par exemple, dans le cas de la maladie asthmatique, est-ce qu'il y a des facteurs déclenchants, ça c'est un élément qui est très important dans le diagnostic des rhénorées, ce qu'on appelle l'unité de temps, du lieu et de l'action, c'est-à-dire que l'apparition de l'écoulement de la rhénorée, il est en rapport avec le temps, est-ce que l'écoulement nasal survient pendant une saison particulière, ou bien il survient pendant toute l'année, c'est ce qu'on a fait avant les rhéniques allergiques saisonnières, par exemple, au cours de la période de pollinisation, on peut avoir l'apparition de la rhénorée avec des symptômes associés qui orientent vers une allergie nasale, ou bien est-ce que l'écoulement est rattaché à une unité du lieu, c'est-à-dire que le patient lorsqu'il rentre dans un lieu particulier, par exemple, dans son lieu de travail, ou bien lorsqu'il rentre chez lui, ou bien dans certaines zones de son domicile, dans certaines chambres, par exemple, où il sent trop humide, mal aéré, et c'est à ce moment-là que se déclenche ce symptôme, cet écoulement, ou bien lorsqu'il manipule certains produits, ce qu'on appelle l'unité de l'action, alors ces trois symptômes lorsqu'ils sont présents, ça oriente vers une allergie, lorsqu'on a une unité de temps, lorsqu'il y a une unité du lieu, ou bien une unité de l'action, ça oriente vers une origine allergique, ça c'est un élément important qui permet de rattacher l'écoulement nasal à des facteurs déclenchants qui sont d'ordre allergique.

Alors, une fois qu'on a fait l'interrogatoire, on dirait la menace, il faut passer à l'examen clinique. L'examen clinique commence toujours par l'inspection du nez, de la face et des postes nasales, et on fera ce qu'on appelle l'arioscopie antérieure à l'aide d'un spiculum. Donc là vous voyez ce qu'on appelle un spiculum nasal, qu'on va appliquer et examiner marine par marine.

L'écartement des ailes du spiculum permet d'élargir un petit peu l'origine narinelle et permet de voir le septum nasal, la paroi externe avec le cornet intérieur, le cornet moyen. C'est un examen qui permet de voir, d'apprécier l'état de la muqueuse, est-ce qu'elle est inflammatoire, est-ce qu'il y a des ulcérations, est-ce qu'il y a une tumeur, est-ce qu'il y a le type de la rhénorée, est-ce qu'il y a des purulentes, est-ce qu'il y a des claires, est-ce qu'il y a des mypistactis. Il permet de voir

est-ce qu'il y a une déviation de la cloison nasale par profil associé, est-ce qu'il y a des polypes associés, surtout au niveau du myomoyen, ou bien parfois est-ce qu'il y a des corps étrangers qui peuvent être présents, c'est-à-dire toucher l'enfant.

C'est un examen qui est très important, mais malheureusement on ne permet pas d'explorer toute la muqueuse de la fosse nasale. D'où l'intérêt de faire ce qu'on appelle une rhinoscopie postérieure, et à ce moment-là, il faudra céder par une source de lumière frontale et un miroir qu'on introduit derrière le voile du palais pour pouvoir explorer le rhinoparax et les coins. C'est un examen qui est un peu difficile et qui nécessite la coopération du patient puisque ça va déclencher le réflexe nauséeux.

C'est pour cela qu'on utilise souvent la nasophibroscope qui, elle, permet, à l'aide d'un fibroscope introduit par le nez, d'explorer toute la muqueuse de la fosse nasale, des cornées, les méas, inférieurs, moyens, supérieurs. Rechercher si il y a une rhinorrhée, si il y a une tumeur, si il y a une inflammation, explorer les coins, explorer le rhinoparax pour rechercher les signes de rhinopharyngite, une inflammation, un jetage postérieur, un écoulement périllant postérieur. Et bien sûr, ça nous aidera à explorer aussi le reste des voies aériennes supérieures, le voile du palais, le rhinoparax, ainsi que le larynx.

Les examens paracliniques qu'on peut demander éventuellement et en fonction de l'orientation étiologique, il y a d'abord les tests cutanés, lorsqu'on suspecte, par exemple, une origine allergique de la rhinorrhée. Des tests cutanés qui vont nous permettre de savoir est-ce qu'il y a une sensibilisation à certains allergènes, quels sont ces allergènes, leur nombre, leur type, et qui va nous aider dans le traitement. Concernant l'imagerie, on peut demander éventuellement une radiographie standard typoblo, lorsqu'on suspecte une sinusite, ou bien au mieux, une TDM nasosinusienne qui va notamment explorer la néphose nasale ainsi que tous les sinus associés.

Alors quelles sont les étiologies des rhinorrhées ? D'abord, on va commencer par les rhinorrhées claires. La couleur est claire. Et ils peuvent évoluer selon deux types.

Soit ce sont des rhinorrhées qui sont claires et pas cystiques, c'est-à-dire qui sont intermittentes. Et là, ils peuvent soit être d'origine allergique ou non allergique. Alors le caractère allergique, on le suspecte déjà à l'interrogatoire, comme on l'a dit au début.

La présence de l'unité du temps, du lieu et de l'action va orienter fortement vers l'origine allergique. En général, les patients qui ont une allergie au pollen, ils sont dérangés beaucoup plus au printemps. Les personnes qui ont une allergie à la poussière, ils sont dérangés lorsqu'ils sont en train de faire, par exemple, des nettoyages de zones un petit peu poussiéreuses.

Lorsqu'ils sont en train de faire le ménage chez eux. Donc là, ces gens-là, ils vont présenter un écoulement nasal, bien sûr associé à d'autres signes tels un crachats nasale, une obstruction, des éternuements en salve. Et les tests cutanés, en général, vont confirmer le diagnostic.

Mais il faut savoir que lorsque les tests cutanés sont négatifs, ça n'élimine pas une origine allergique. Puisque le patient peut être allergique à d'autres types d'allergènes qui ne sont pas utilisés dans les tests cutanés. Les rhinites vasomotrices, ou ce qu'on appelle rhinites idiopathiques, sont en rapport avec un dysfonctionnement neurovasculaire de la muqueuse nasale dont l'origine n'est pas étiquetée.

Alors toujours dans les rhinorrhées claires, mais dans ce cas-là, ce sont des rhinorrhées qui sont continues, c'est-à-dire qui sont tout le temps présentes. Elles ne sont pas en rapport avec des unités de durée de temps. Donc l'étiologie ici, essentiellement, c'est ce qu'on appelle la rhinorrhée cérébrose finale.

Il y a la rhinodécroée, c'est-à-dire un écoulement du LCR au niveau des fosses nasales. Soit antérieure, soit postérieure, et qui est en rapport avec une brèche ostéoméningique. C'est-à-dire qu'il y a une communication entre les espaces sous-arachnoïdiens et les cavités mastoïdiennes.

Donc ça peut être en rapport avec un traumatisme, une fracture par exemple au niveau de l'étage antérieur de la base du crâne, ou bien après une chirurgie éventuellement, ou bien dans le cadre d'une hypertension intracrânienne non traitée. Alors le diagnostic sera suspecté sur le caractère clair de la rhinorrhée, sur le caractère continu, et surtout par la présence des signes du réservoir. C'est-à-dire qu'on demande au patient de se pencher en avant, et on va voir qu'il y aura apparition ou bien accentuation de l'écoulement nasal.

Deuxième partie des rhinorrhées, c'est les rhinorrhées purulentes. Dans ce cas-là, elles vont être soit jaunâtres ou bien verdâtres. Dans les rhinorrhées purulentes unilatérales, il faut bien sûr évoquer en premier le corps étranger des fosses nasales, surtout chez l'enfant.

Ça c'est un réflexe qu'il faut avoir. Cet enfant qui a une rhinorrhée purulente unilatérale, il faut d'abord éliminer un corps étranger, c'est une cause qui est très très fréquente. Deuxième, c'est la sinusite bactérienne, souvent d'origine dentaire, d'où l'intérêt d'examiner l'arcade dentaire, rechercher s'il y a des caries dentaires qui sont associées.

Dans ce cas-là, en plus de la rhinorrhée, le patient va avoir des algues faciales, frontales, sous-orbitales, en regard de la racine du nez, en fonction du sinus qui est atteint. On peut avoir une tumeur nasale ou naso-sinusienne. Dans ce cas-là, on aura une rhinorrhée purulente associée ou bien mêlée avec du sang, associée à des algues faciales, des chutes dentaires, une tumeur faciale et obstruction nasale éventuelle.

Deuxième partie, c'est les rhinorrhées purulentes qui sont bilatérales. Dans ce cas-là, il faudra penser beaucoup plus à une rhinosinusite, une maladie de la muqueuse, qui en est responsable. Toujours dans les idéologies des rhinorrhées, il y a les rhinorrhées sanglantes, ce qu'on appelle les épistaxis.

Ce sont des saignements qui proviennent de la muqueuse naso-sinusienne. D'abord, il faut évaluer la gravité du saignement, c'est-à-dire ce qu'on a une importance, une hémorragie très importante, où il y a des saignements qui sont minimes, et évaluer le retentissement. Le patient qui a une épistaxis peut saigner par en avant, c'est-à-dire par les narines.

Comme il peut avoir une épistaxis postérieure, de l'intérêt de faire un examen de l'orant par axe pour voir s'il y a un saignement qui passe à travers l'équation de l'orant par axe et qui peut passer inaperçu. On évaluera le retentissement général en explorant les conjonctives qui sont décolorées, prendre l'attention artérielle, prendre le pot pour voir si on est devant une hypotension ou bien carrément des états de choc. Les idéologies sont multiples.

D'abord, il y a les causes générales. L'hypertension artérielle est parmi les causes fréquentes d'épistaxis. En général, ça donne des saignements unilatéraux, souvent du siège postérieur, d'où le réflexe de toujours prendre l'attention artérielle devant tout patient qui a une épistaxis.

Les troubles de l'hémostase, soit c'est des patients qui sont sous anticoagulants, sous épargne, sous AVK, sous aspirine à faible dose, ou bien des patients qui présentent des hémopathies qui, elles, entraînent par exemple des thrombopédies qui peuvent être la cause de l'épistase. On peut être devant des causes locales. En général, les traumatismes de la face peuvent entraîner des lésions de la muqueuse associées à des fractures.

Des tumeurs, qu'elles soient bénignes ou malignes. Chez l'enfant, le grand enfant ou l'adolescent, on recherchera ce qu'on appelle l'ongiofibrome. Il y a un fibrome nasopharyngien, une tumeur qui est postérieure et qui se manifeste par des épistaxis récidivants associées à une obstruction nasale d'installation progressive.

Ou bien on peut avoir des tumeurs malignes, telles la dénoncarcinome épimide ou bien la décarcinome épidermoïde. La cause la plus fréquente des épistaxis, surtout chez l'enfant et l'adulte jeune, c'est les tâches vasculaires. Ce qu'on appelle les épistaxis essentielles sur tâches vasculaires, c'est le saignement du siège antérieur en rapport avec la zone d'anastomose entre le système carotidien interne et externe, zone de fragilité vasculaire.

Cela reste un diagnostic d'élimination, c'est-à-dire il faut bien sûr avant de retenir ce diagnostic, essayer d'explorer toute la muqueuse nasale, éliminer est-ce qu'il y a une tumeur associée, est-ce qu'il y a une pathologie associée. Après, on va retenir ce diagnostic par la présence de télangiectasies accentuées au niveau de la tâche vasculaire ou bien en visualisant carrément le point de saignement.